

УДК:614.2

К.Ш.Нургазиев, Д.М.Байпеисов, Э.Т.Ауезова, Д.Г.Адилбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Результаты внедрения системы мониторинга и оценки онкологической службы в Республике Казахстан

Аннотация. В статье освещены вопросы внедрения системы мониторинга и оценки онкологической службы в РК. Поэтапно описаны основы мониторинга и оценки (МиО) в здравоохранении, процесс создания положений и индикаторов МиО онкослужбы, обучение координаторов групп мониторинга и результаты первых выездов в регионы.

Ключевые слова: Мониторинг и оценка, онкослужба, КазНИИОиР.

Снижение смертности от онкологических заболеваний – одна из приоритетных задач системы здравоохранения РК, и, в частности, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) и всей службы онкологии [1]. Институтом осуществляется регулярный сбор информации, измеряются полученные показатели, оцениваются результаты, составляются отчеты на уровне района, города, области, республики [2].

Мониторинг и оценка являются важным компонентом в противораковой борьбе, в реализации Программы развития онкологической помощи населению РК на 2012 – 2016 годы, Стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан и других нормативно-правовых актов. Аналитическая информация, формируемая при проведении мониторинга, дает возможность принимать объективные управленческие и стратегические решения.

Система мониторинга и оценки позволяет выявить положительные стороны и недостатки онкослужбы, разработать методические рекомендации, оценить уровень коммуникаций с другими секторами здравоохранения [3,4]. Выделяют основные методы проведения мониторинга:

- изучение документации,
- изучение отчетных материалов,
- непосредственное наблюдение и интервью.

Изучение документации предусматривает просмотр медицинской документации, просмотр ежемесячных и ежеквартальных форм отчетности.

Путем мониторингового визита можно провести непосредственное наблюдение за действиями персонала во время работы.

Интервью – это спланированная беседа с целью выявления существующих проблем и изучения знаний меди-

цинского работника об определенном аспекте работы. Непосредственное интервью выявляет знания медицинского персонала, узнать мнение пациента об уровне оказания медицинской помощи и медицинской практики, и, тем самым, определить причины существующих проблем. Использование этих методов в совокупности приводит к выявлению тех или иных несоответствий установленным стандартам, наметить пути решения к устранению причины.

На основании поручения Министра здравоохранения и социального развития от 14.11.2014 года, с целью повышения эффективности деятельности онкологической службы РК, улучшения взаимодействия и преемственности в деятельности Управлений здравоохранения, республиканских и региональных онкологических организаций, были разработаны положение о группах мониторинга, функциональные обязанности, определена частота выездов и уровни мониторинга.

В онкологической службе РК определены следующие аспекты мониторинга:

- персонал и инфраструктура службы,
- система регистрации пациентов,
- достоверность статистических данных и уровень информатизации, их когортный анализ;
- доступность химиотерапевтических и таргетных препаратов для лечебных учреждений,
- правильность прогнозирования расходов химиопрепаратов на будущий год,
- взаимодействие онкологической службы с другими ведомствами и службами здравоохранения (ПМСП),
- качество и эффективность лечения онкологических пациентов,
- эффективность скринингов (РМЖ, РШМ, РПиЖ, КРР, РП и РПЖ) в раннем выявлении онкологических заболеваний [5].

В ноябре 2014 года была сформирована рабочая группа для разработки индикаторов оценки онкологической службы на всех уровнях. Были разработаны более 40 контрольных листов, включающих все этапы оказания онкологической помощи, начиная от регистратуры АПО до работы онкологических диспансеров.

Разработка индикаторов осуществлялась в соответствии с критериями, представленными в таблице №1.

Таблица 1 - Критерии отбора индикаторов

Характеристика	Описание
Действительность	Показатели должны измерять условия или события, для измерения которых эти показатели предназначены
Надежность	Показатели должны быть объективными, давать одинаковые результаты, когда проводится более одного измерения одинаковых условий или событий. Все должно быть эквивалентным (н-р должны использоваться одинаковые методы / приборы/ инструменты)
Специфичность	Показатели должны измерять одни и те же условия или события
Чувствительность	Показатели должны отражать изменения условий или событий в процессе наблюдения
Оперативность	Показатели должны быть соизмеримы с определениями, которые разработаны и тестированы на уровне программы
Допустимость	Стоимость измерения показателей должна быть разумной
Выполнимость	Должна иметься возможность осуществлять сбор предложенных данных при нормальных условиях работы
Измеримость	Показатель должен быть измерен объективно
Сравнимость	Показатели должны быть сопоставимы по времени и по различным географическим зонам

Индикаторы сгруппированы в контрольные листы, которые в свою очередь разделены по объекту проведения мониторинга. Так, в сборнике контрольных листов имеются такие листы как, администрация АПО, маммологический кабинет, центр паллиативной помощи и другие. Индикаторы в контрольных листах поделены на три основных типа [6]:

- Индикаторы структуры – осуществляют мониторинг наличия или отсутствия материально-технической базы, нормативно-правовой информации и другие;
- Индикаторы процесса – предназначены для мониторинга деятельности, и проводятся в виде непосред-

ственного интервью или наблюдения;

- Индикаторы результата – это числовые индикаторы, которые необходимо высчитывать, используя цифры, полученные в ходе мониторинга и формулы, представленные в описательной части.

Национальные и региональные группы мониторинга и оценки онкологической службы были созданы на основании 14) пп.1 п.1 протокольного поручения Вице – министра здравоохранения и социального развития от 16 февраля 2015 года. Так, на основании поручения в феврале 2015 года в КазНИИОнР были созданы 5 национальных подгрупп МиО онкологической службы (рисунок 1).



Рисунок 1 - Уровни мониторинга и оценки

Следующим этапом, в связи с внедрением системы мониторинга и оценки, 13-14 апреля 2015 года на базе КазНИИОиР проведен обучающий семинар по вопросам мониторинга и оценки онкологической службы РК, куда были приглашены все члены национальной группы МиО, а также руководители и заместители всех региональных групп МиО.

В течение двух дней сотрудниками КазНИИОиР, проведено более 20 лекций, затрагивающих все аспекты мониторинга и оценки службы в разрезе подготовленных

индикаторов и нормативно-правовых актов РК. Были проведены лекции по основам МиО онкослужбы, по особенностям нормативно правовых актов, по работе с контрольными листами и индикаторами и проведен детальный обзор всех разработанных индикаторов структуры, процесса и результата.

После проведенного инструктажа и интенсивного обучения в мае 2015 года осуществлены первые выезды 5 национальных подгрупп МиО в регионы согласно таблицы 2.

Таблица 2 – Расписание выездов национальных подгрупп МиО

Наименование подгруппы	Регионы	Даты выездов
Восточная	Карагандинская область	20-24 апреля 2015г.
Южная 1	Алматинская область	20-24 апреля 2015г.
Западная	Актюбинская область	04 – 08 мая 2015г.
Южная 2	Кызылординская область	04 – 08 мая 2015г.
Северная	г. Астана.	04 – 08 мая 2015г.

В каждый регион согласно положениям по МиО, командированы по 5-6 членов национальных групп мониторинга. Был составлен примерный график мониторинга длительностью 5 дней. Первые 2 дня посвящены работе онкологического диспансера области, остальные три дня учреждениям ПМСП. Основной упор сделан на соблюдении маршрута движения пациента, соблюдения сроков обследования, госпитализации в специализированное учреждение и качество проведения скрининга [7].

Результаты работы национальной группы МиО были предоставлены в МЗ СР РК, УЗ соответствующих областей и руководителям онкологических диспансеров.

На основании мониторинга и оценки выявлены несоответствия в работе, как самих диспансеров, так и первичного звена. Многие замечания были универсальны для всех регионов, такие как не соблюдение маршрута пациента в АПО, отсутствие мужских смотровых кабин-

тов, низкий процент охвата первичных больных смотровым кабинетом, проблемы с организацией скрининга, несоблюдение приказа №885 по диспансеризации предраковых заболеваний и доброкачественных опухолей, проблемы с организацией проф. осмотра лиц 65 лет и старше, отклонение лечения или диагностики от ППДиЛ и другие. По всем выявленным недостаткам членами групп МиО был проведен инструктаж по устранению замечаний и улучшению качества работы как в АПО, так и в ОД.

Эффективная реализация вышеуказанных мероприятий позволит улучшить качество оказания медицинской помощи онкологическим больным, приблизить онкологическую службу Республики к международному уровню и в конечном итоге снизить смертность от злокачественных новообразований.



Рисунок 2 - Итоговый отчет МиО

Список литературы

1. Программа развития онкологической помощи в Республике Казахстан на 2012–2016 годы.
2. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 540 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь населению Республики Казахстан».
3. Campbell S.M., Braspenning J., Hutchinson A., Marshall M. Research methods used in developing and applying quality indicators in primary care // Qual Saf. Health Care. - 2002. - Vol. 11. - P.358-64.
4. Исмаилов Ш.Ш., Назирова Н.И., Токтабаянова А. Методические рекомендации по мониторингу и оценке противотуберкулезных мероприятий в Республике Казахстан. - Астана, 2008.
5. Ashbury F.D. and Cameron C. National performance indicators for cervical cancer screening: interim report. - Ottawa, HealthCanada, 2000.
6. Smith P.C., Mossialos E., Papanicolas I. Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. Background Document for WHO European Ministerial Conference on Health Systems: "Health Systems, Health and Wealth". - Copenhagen, World Health Organization, Europe, 2008.
7. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 885 «Об утверждении протоколов (стандартов) диспансеризации больных с хроническими формами заболеваний»

Тұжырым

К.Ш.Нургазиев, Д.М.Байпеисов, Э.Т.Ауезова,
Д.Т.Адилбай

Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты

Қазақстан Республикасының онкология қызметін
мониторинг және бағалау жүйесін енгізу нәтижелері

Мақалада, онкология қызметінің мониторинг және
бағалау жүйесін енгізуінің барысы байандалған. Монито-
ринг және бағалау жүйесінің негізінен, мониторинг және
бағалау көрсеткіштерін құру процесінен бастап,

мониторинг және бағалау қызметкерлерін оқыту мен
облыстарға бірінші сапарды нәтижелері ашылған.

Түйінді сөздер: Мониторинг және бағалау, онколо-
гия қызметі, ОЖРҚазҒЗИ

Summary

Nurgaziyev K.Sh., Baipeisov D.M., Auyezova E.T., Adilbay
D.G.

Kazakh Institute of oncology and radiology

Monitoring and evaluation of cancer service in
Kazakhstan

Implementing challenges of monitoring and evaluation
in Kazakhstan cancer service outlined in this paper. Step
by step, principles of monitoring in health care, process
of indicator selection in cancer service, education of
coordinators and results of first visits to regions described.

Keywords: Monitoring and evaluation, cancer service,
Kaz.Inst. of oncology and radiology